

Hernias (inguinal, umbilical, femoral, epigástrica)

1. Introducción y relevancia clínica

Las **hernias abdominales** son protrusiones de vísceras o tejidos intraabdominales a través de un defecto de la pared abdominal.

Son una de las **patologías quirúrgicas más frecuentes**, con alta incidencia en varones y en edades medias o avanzadas.

Las **hernias inguinales** representan aproximadamente **75% de todos los casos**, seguidas por las **umbilicales (10%)**, **femorales (5%)** y **epigástricas (3–5%)**.

Aunque muchas son asintomáticas o reducibles, el riesgo clínico principal es su **encarcelamiento o estrangulación**, que constituye una **urgencia quirúrgica**.

En Chile, la **hernia inguinal es GES** para mayores de 15 años desde 2019, garantizando tratamiento quirúrgico oportuno y de calidad.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Conceptos fundamentales

- Una **hernia** ocurre cuando existe una **debilidad o defecto** en la pared abdominal, que permite el paso del contenido intraabdominal (intestino, grasa, epiplón).
- Estructuralmente consta de:
 - **Anillo herniario** (defecto fascial).
 - **Saco herniario** (peritoneo parietal protruyente).
 - **Contenido herniario** (víscera o grasa preperitoneal).

2.2 Factores predisponentes

- **Congénitos**: persistencia del proceso vaginal (hernia inguinal indirecta).
- **Adquiridos**: aumento de la presión intraabdominal (tos crónica, obesidad, ascitis, esfuerzo, embarazo), debilidad muscular (edad avanzada, desnutrición) y cirugía

previa (hernia incisional).

2.3 Clasificación anatómica general

Tipo	Sitio	Características
Inguinal indirecta	A través del conducto inguinal, por anillo profundo, lateral a vasos epigástricos	Congénita (persistencia del proceso vaginal)
Inguinal directa	Por debilidad de la pared posterior (triángulo de Hesselbach), medial a vasos epigástricos	Adquirida
Femoral	Debajo del ligamento inguinal, a través del canal femoral	Más frecuente en mujeres, alto riesgo de estrangulación
Umbilical	En línea media, a nivel del ombligo	Asociada a obesidad, multiparidad
Epigástrica	En línea alba, entre apéndice xifoides y ombligo	Contiene grasa preperitoneal
Incisional	En sitio de cirugía previa	Falla de cierre o infección de herida

2.4 Mecanismos de complicación

- **Encarcelación:** el contenido herniario no puede reducirse, pero **sin compromiso vascular**.
- **Estrangulación:** se compromete el flujo sanguíneo → **isquemia, necrosis y peritonitis** si no se opera rápidamente.
 - Ocurre más en hernias **femorales y inguinales indirectas pequeñas**.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones generales

- **Tumoración o abultamiento** en región inguinal, umbilical o abdominal.
- **Aumenta con maniobras de Valsalva** (tos, esfuerzo) y **disminuye o desaparece en reposo o decúbito**.
- **Molestia o dolor sordo**, que puede progresar con el tiempo.

3.2 Diagnóstico físico según localización

A. Hernia inguinal

- **Indirecta**: abultamiento oblicuo hacia el escroto; palpable en el **anillo inguinal profundo**, lateral a vasos epigástricos.
- **Directa**: masa redondeada en región medial del triángulo de Hesselbach; **no desciende al escroto**.
- **Reductible** con presión manual.
- **“Tos palpable positiva”**: impulso herniario con la tos.

B. Hernia femoral

- Tumoración **inferior al ligamento inguinal**, pequeña y dura, con mayor incidencia en mujeres.
- Dolorosa, **frecuentemente encarcelada o estrangulada**.

C. Hernia umbilical

- Masa redondeada en el ombligo; en adultos puede contener epiplón o intestino.
- Frecuente en multiparidad o ascitis.

D. Hernia epigástrica

- Masa pequeña en línea media superior (entre ombligo y apéndice xifoides).
- Puede ser múltiple y dolorosa.

3.3 Signos de complicación

Signo	Significado
Dolor intenso, constante	Sufrimiento o estrangulación
Eritema o calor local	Isquemia o infección
Masa irreductible	Encarcelación
Náuseas, vómitos, íleo	Obstrucción intestinal
Fiebre, leucocitosis, acidosis	Estrangulación avanzada

☐ Toda hernia **no reductible + dolorosa** se considera **estrangulada** hasta demostrar lo contrario.

3.4 Diagnóstico diferencial

- Linfadenitis inguinal.
- Varicocele.
- Hidrocele.
- Lipoma de cordón espermático.
- Absceso subcutáneo.
- Aneurisma femoral.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El **diagnóstico es clínico en la mayoría de los casos**. Sin embargo, los estudios de imagen pueden ser útiles en casos dudosos o recidivantes.

Examen	Utilidad
Ecografía inguinal o de pared	Primer examen de elección; detecta contenido herniario y su movilidad.
TAC abdominopélvico	En hernias complicadas o de diagnóstico incierto. Define anatomía, contenido y signos de estrangulación.
RMN	En pacientes obesos o con cirugía previa. Alta sensibilidad para hernias pequeñas o femorales.

5. Tratamiento (según guías MINSAL y HerniaSur 2021)

5.1 Principios generales

- El **tratamiento definitivo siempre es quirúrgico**.
- No existen fajas ni medicamentos que “curen” una hernia.
- La cirugía busca **reducir el saco herniario y reforzar la pared** para prevenir recurrencias.

5.2 Tratamiento electivo (hernia no complicada)

A. Hernia inguinal

- **Técnica estándar: hernioplastia inguinal con malla (Lichtenstein).**

- Se coloca una malla de polipropileno sobre la pared posterior del conducto inguinal.
 - Baja recurrencia (<2%).
- Alternativas mínimamente invasivas:
 - **TEP** (total extraperitoneal).
 - **TAPP** (transabdominal preperitoneal).
 - Indicadas en bilateralidad o recidiva.

B. Hernia umbilical y epigástrica

- Herniorrafia simple si <2 cm.
- Con malla si >2 cm o en adultos obesos (disminuye recurrencias).

C. Hernia femoral

- Cirugía **siempre indicada**, incluso si asintomática, por alto riesgo de estrangulación.
- Reparación con malla (abierta o laparoscópica).

5.3 Tratamiento de urgencia (hernia complicada)

- **Hospitalización inmediata.**
- **Ayuno y fluidoterapia.**
- **Profilaxis antibiótica (cefazolina o ceftriaxona + metronidazol).**
- **Cirugía urgente:**
 - **Reducción del contenido.**
 - Evaluación de viabilidad intestinal.
 - Resección si hay necrosis.
 - **Reparación sin tensión**; si contaminación: herniorrafia sin malla.

- ☐ En hernia estrangulada con necrosis intestinal → resección intestinal + herniorrafia (sin malla).
-

5.4 Indicación de malla

Condición	Uso de malla
Hernia electiva sin contaminación	✓ Sí
Hernia encarcelada sin necrosis	✓ Sí (tras reducción)
Hernia estrangulada con resección intestinal	☐ No (riesgo de infección)

5.5 Cuidados postoperatorios

- Deambulación precoz.
 - Analgesia oral o parenteral.
 - Evitar esfuerzos 4–6 semanas.
 - Control de herida quirúrgica.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Frecuencia	Manejo
Seroma/Hematoma	5–10%	Drenaje o compresión local

Infección de herida o malla	1–3%	Antibióticos ± extracción de malla
Recidiva herniaria	<2% (con malla)	Reintervención
Dolor crónico inguinal (neuralgia)	5–15%	Analgésicos, bloqueos nerviosos
Lesión intestinal o vesical	<1%	Reparación quirúrgica inmediata

Pronóstico: excelente en hernias tratadas electivamente (<1% mortalidad).

Mortalidad aumenta a **10–20%** en hernias estranguladas con necrosis intestinal.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Toda masa reducible inguinal o umbilical que aumenta con Valsalva = hernia.**
 2. **Dolor + masa irreducible** = encarcelación; si hay fiebre, eritema o vómitos → **estrangulación (urgencia quirúrgica).**
 3. **Hernia femoral:** más frecuente en mujeres, **alto riesgo de estrangulación**, operar siempre.
 4. **Lichtenstein con malla** es el tratamiento estándar de la hernia inguinal.
 5. No se debe intentar reducir **manualmente una hernia dolorosa y caliente** (puede contener intestino necrótico).
 6. **Ecografía inguinal** útil en casos atípicos o pacientes obesos.
 7. En cirugía de urgencia con contaminación, **no se usa malla** (riesgo de infección).
-



Errores comunes

- Observar hernias femorales asintomáticas (riesgo alto de estrangulación).
 - Intentar **reducir hernia estrangulada sin anestesia ni imagen previa**.
 - No reconocer **hernias pequeñas** pero dolorosas (frecuente en mujeres delgadas).
 - No indicar cirugía en hernia umbilical >2 cm o sintomática.
 - Omitir **profilaxis antibiótica** en cirugía urgente.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Hernia = defecto de pared abdominal con protrusión de vísceras.**
2. Las más frecuentes: **inguinal (indirecta y directa), umbilical, femoral y epigástrica.**
3. **Principal complicación: estrangulación intestinal → urgencia quirúrgica.**
4. **Diagnóstico clínico;** usar ecografía o TAC si duda.
5. **Tratamiento quirúrgico** definitivo (malla si no hay contaminación).
6. **Lichtenstein** es el estándar en hernia inguinal.
7. **Hernia femoral = operar siempre**, por su alto riesgo de necrosis.